



Périmètre limité : le document source HAS (2014) comporte 4 parties. Cette fiche couvre INTÉGRALEMENT la seule **Partie 2 — Anesthésie, réanimation, chirurgie, urgence** (sections 5 à 8). Les Parties 1 (produits/qualifications de CGR — médecine transfusionnelle générale), 3 (hématologie-oncologie : drépanocytose, thalassémie, leucémies) et 4 (néonatalogie : exsanguino-transfusion) ne sont PAS traitées — hors périmètre anesthésie/réanimation adulte de ce corpus, disclosed explicitement.

Grille HAS (distincte du format SFAR 1+/1-/2+/2- utilisé ailleurs dans ce corpus) — **A** : preuve scientifique établie ; **B** : présomption scientifique ; **C** : faible niveau de preuve ; **AE** : accord d'experts (absence d'études) ; **ABS** : absence de recommandation. Fiche limitée à la Partie 2 du source (anesthésie/réanimation/chirurgie/urgence) — voir encadré de périmètre ci-dessous.

A	B	C	AE	ABS
----------	----------	----------	-----------	------------

Section 5.1 — Seuil transfusionnel en anesthésie

Réf.	Recommandation	Grade
—	Le seuil critique du transport artériel en O ₂ (TaO ₂ crit) chez l'homme anesthésié est de l'ordre de 5 ml O ₂ /kg/min (repère physiologique).	B
—	Pour conserver une marge de sécurité, le seuil de sécurité du TaO ₂ recommandé chez l'adulte est de 10 ml O ₂ /kg/min. La tolérance à l'anémie aiguë dépend des possibilités d'augmentation du débit cardiaque — d'où la priorité à corriger l'hypovolémie, et un seuil plus élevé en cas d'insuffisance cardiaque.	AE
—	Seuils transfusionnels d'hémoglobine en période péri-opératoire : 7 g/dl chez les personnes sans antécédents particuliers ; 10 g/dl chez les personnes ne tolérant pas cliniquement des concentrations inférieures, ou atteintes d'insuffisance coronarienne aiguë, d'insuffisance cardiaque avérée, ou bêta-bloquées.	B
—	Privilégier un seuil transfusionnel de 8-9 g/dl chez les personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires.	AE

Section 5.2 — Seuil transfusionnel en réanimation

Réf.	Recommandation	Grade
—	Seuil transfusionnel de 7 g/dl en l'absence d'insuffisance coronarienne aiguë (y compris chez les patients à cardiopathie chronique équilibrée) ; 10 g/dl d'Hb en présence d'une insuffisance coronarienne aiguë.	B
—	Patient traumatisé (hors traumatisme crânien) et hors transfusion massive : seuil transfusionnel de 7 g/dl en l'absence de mauvaise tolérance clinique.	B
—	Hémorragie digestive (bonne tolérance clinique, absence de signe de choc) : seuil transfusionnel de 7 g/dl.	B

Précision du source (non gradée séparément) : chez le patient traumatisé, viser une Hb entre 7 et 9 g/dl en tenant compte de la cinétique du saignement. En transfusion massive, associer les CGR à du plasma thérapeutique et des concentrés de plaquettes — en dehors de ce cadre, ne pas associer systématiquement plasma et CGR (précisions non gradées séparément).

ABS — Absence de recommandation (données insuffisantes) : seuil transfusionnel en neuroréanimation — données insuffisantes et résultats contradictoires.

ABS — Absence de recommandation (données insuffisantes) : âge/durée de conservation des CGR (Section 5.3) — données disponibles insuffisantes.



Section 6 — Niveaux d'urgence transfusionnelle

Définitions (Afssaps 2002) : urgence vitale immédiate (UVI) — délivrance sans délai ; urgence vitale (UV) — obtention en < 30 min ; urgence relative (UR) — obtention en 2-3 h.

Réf.	Recommandation	Grade
—	Le délai d'obtention des CGR prime sur celui des résultats d'examens immuno-hématologiques.	AE

Section 7 — Transfusion en situation d'urgence

Réf.	Recommandation	Grade
—	Chaque établissement doit disposer d'une procédure d'urgence vitale propre, discutée avec la structure de délivrance (circuits, modalités d'acheminement, stock de dépôt d'urgence).	AE
—	En l'absence de résultat de groupe ABO disponible, ou en cas de doute sur le lien patient-examens, transfuser des CGR de groupe O.	AE
—	Sans aucune donnée immuno-hématologique : CGR O RH:1 KEL:-1 — sauf pour la femme de la naissance à la fin de la période procréatrice, pour laquelle des CGR O RH:-1 KEL:-1 sont recommandés en 1 ^{re} intention (dans la limite des disponibilités). Avec une seule détermination ABO-RH1/RH-KEL1 disponible, délivrer un CGR groupe O compatible avec ce phénotype si disponible dans les délais.	AE
—	Communiquer les données d'identité les plus complètes possible (a minima sexe et âge, avec tout document disponible), pour affiner la sélection des CGR ou retrouver l'historique du patient.	AE
—	Femme de groupe RH:1 connu, phénotype RH4 négatif ou inconnu : ne pas transfuser de CGR RH:-1 de la naissance à la fin de la période procréatrice.	AE
—	En transfusion massive, la disponibilité des CGR prime sur la compatibilité dans les systèmes de groupes sanguins hors ABO.	AE

Section 8.1-8.2 — Alternatives : fer et EPO

Réf.	Recommandation	Grade
8.1	Le fer est recommandé en anesthésie uniquement en présence d'une carence martiale.	B
8.1	L'utilisation systématique du fer n'est pas recommandée en réanimation.	C
8.2	L'EPO n'est pas recommandée en réanimation.	B
8.2	L'EPO est recommandée en préopératoire de chirurgie orthopédique hémorragique chez les patients modérément anémiques (Hb 10-13 g/dl attendant des pertes de 900-1 800 ml).	A
8.2	L'EPO n'est pas recommandée en péri-opératoire de chirurgie colorectale carcinologique (insuffisance de preuve d'efficacité).	B



Section 8.3-8.4 — Alternatives : acide tranexamique et rFVIIa

Réf.	Recommandation	Grade
8.3	Utiliser l'acide tranexamique en péri-opératoire de chirurgie hémorragique, sauf contre-indication (antécédents thromboemboliques veineux/artériels, antécédents convulsifs — contre-indications relatives ; adapter la dose si insuffisance rénale).	B
8.3	Utiliser l'acide tranexamique dans les 3 premières heures de prise en charge d'un polytraumatisme : 1 g IV lente sur 10 min, puis 1 g sur 8 h.	A
8.4	Ne pas administrer systématiquement le facteur VIIa recombinant (rFVIIa) en anesthésie.	A
8.4	Ne pas administrer systématiquement le rFVIIa en traumatologie (réanimation).	B

ABS — Absence de recommandation (données insuffisantes) : acide tranexamique dans l'hémorragie du post-partum — insuffisance de données sur la balance bénéfice/risque.

ABS — Absence de recommandation (données insuffisantes) : rFVIIa dans l'hémorragie du post-partum — insuffisance de preuve d'efficacité.

Section 8.5-8.6 — Retransfusion et transfusion autologue

Réf.	Recommandation	Grade
8.5	Récupération de sang peropératoire : meilleures indications en chirurgie cardiaque et vasculaire ; non recommandée si champ opératoire infecté ou colles biologiques utilisées ; volumes non lavés $\leq 1\,000$ ml par patient adulte (au-delà, lavage requis).	AE
8.5	Récupération de sang postopératoire : meilleures indications en arthroplastie de genou et hémithorax ; recueil limité aux 6 premières heures postopératoires ; non recommandée en cas d'infection (locale ou générale) ou d'insuffisance rénale.	AE
8.6	Ne pas proposer de transfusion autologue programmée (TAP), sauf groupe sanguin rare ou patient polyimmunisé.	AE

Sources et avertissement

Document source : HAS, « Transfusion de globules rouges homologues : produits, indications, alternatives », recommandation de bonne pratique, adoptée par le Collège de la HAS en novembre 2014 (Service des bonnes pratiques professionnelles).

URL source : <https://sfar.org/transfusion-de-globules-rouges-homologues-produits-indications-alternatives/>

Couverture : intégralité de la Partie 2 du source (sections 5 à 8 — anesthésie, réanimation, chirurgie, urgence) : 26 recommandations gradées et 4 absences de recommandation explicites. Les Parties 1, 3 et 4 du document (médecine transfusionnelle générale, hématologie-oncologie, néonatalogie) ne sont pas couvertes — hors périmètre anesthésie/réanimation adulte de ce corpus, disclosed en page 1. Bibliographie et argumentaire scientifique détaillé (document séparé sur has-sante.fr) non reproduits.

Avvertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Partie 2 uniquement), produite pour un usage d'aide-mémoire en anesthésie-réanimation adulte. Elle ne remplace pas le texte intégral — en particulier pour toute situation d'hématologie-oncologie, de pédiatrie ou de néonatalogie, se référer aux Parties 1, 3 et 4 du document HAS complet. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la HAS.